Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

# SENTENÇA

Autos 0804927-82.2018.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Karen Vitória Leal de Araújo
Réu: Município de Paranaíba e outro

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Karen Vitória Leal de Araújo, representada por sua genitora Eva Pereira Leal, em face do Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Paranaíba - MS, todos devidamente qualificados nos autos, em que a parte autora objetiva a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos denominados "Keppra 750 mg, Keppra 250 mg, Baclofeno 10 mg, Domperidona 10 mg e Frisium 10 mg", uma vez que é portadora de "Sequelas de Hipóxia Perinatal", ressaltando que a demora no fornecimento da medicação poderá agravar seu quadro clínico. Aduz que não possui condições financeiras para arcar com os custos mensais da compra dos referidos fármacos sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares. Discorre sobre o dever constitucional do Estado em promover, proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, não podendo outorgá-lo a quem não possui condições. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, dada a urgência e gravidade do caso e a procedência da demanda.

O parecer técnico do N.A.T. encontra-se às fls. 18/29.

O Estado de Mato Grosso do Sul manifestou-se acerca do pedido de tutela de urgência e apresentou contestação às f. 40/47, onde discorreu acerca do não cabimento da tutela antecipada contra a fazenda pública, da inexistência do requisito alusivo ao perigo de demora para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, da falta de interesse, da tese firmada pelo STJ com eficácia vinculante, da ausência de



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

prova da imprescindibilidade e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, da imposição de sequestro de verba pública e da impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Às f. 50/55, o Município de Paranaíba se manifestou acerca do pedido de tutela antecipada.

Em Decisões Interlocutórias de fls. 56/64, o pedido liminar foi parcialmente deferido.

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos documentos médicos (fls. 71/72).

Às fls. 84/100, o Município de Paranaíba - MS apresentou contestação, alegando preliminarmente a falta de interesse processual da parte autora. Afirmou ainda que a parte autora dispõe de tratamento pela rede pública de saúde e não provou que teve seus direitos negligenciados. Reiterou os pedidos para que o tratamento seja realizado pelo SUS e, no caso de procedência, para que os medicamentos possam ser substituídos por medicação genérica.

O Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente ao pedido inicial (fls. 112/117).

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 118), a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 112), enquanto o Estado de Mato Grosso do Sul se manifestou à fl. 125 e o Município de Paranaíba – MS quedou-se inerte (fl. 127).

*É o relato. Decido.*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Karen Vitória Leal de Araújo, em face do Município de Paranaíba e do Estado de Mato Grosso do Sul, todos devidamente qualificados nos autos.

Sustentam os réus que falta interesse processual à autora para a presente demanda, sob o fundamento de que a parte não esgotou as vias administrativas antes de ingressar em juízo.

Não merece guarida a alegação, visto que o esgotamento da discussão na esfera administrativa não é imprescindível para a discussão judicial. Ademais, a contestação da parte ré demonstra sua resistência à pretensão da autora, tornando certa a falta de êxito no pedido administrativo, razão pela qual rejeito a reportada preliminar.

Nestes termos, rejeito a preliminar de falta de interesse processual dos réus e, não havendo outras questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

Como se sabe, o magistrado tem o poder de decidir sobre a real necessidade da dilação probatória, de tal sorte que, entendendo que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão.

A doutrina explana o seguinte entendimento:

> *"(...) o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória,*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais (...)"* (Antônio Carlos Marcato *in* Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983)

*"(...) Em verdade, no princípio da avaliação da prova encontram-se englobados todos os conteúdos do livre convencimento, da motivação e da persuasão, pois todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados (...)"* (Rui Portanova *in* Princípios do Processo Civil. São Paulo: Editora Livraria do Advogado, 2003. p. 218-219)

Colaciono o entendimento do e. TJMS:

*"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADAS – MÉRITO – FORNECIMENTO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS AOS NECESSITADOS – OBRIGAÇÃO QUE É IMPOSTA A TODOS OS DEVEDORES, DE FORMA SOLIDÁRIA (...) cabe ao julgador avaliar as provas produzidas, sendo que se na visão do magistrado as provas apresentadas nos autos mostraram-se adequadas e suficientes, deve ser prestigiada a valoração do conjunto probatório e o livre convencimento motivado que lhe foi conferido, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. (...)"* (TJMS – AC 2011.019030-3. Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, 3ª Turma Cível. Julgado em 19/07/2011) Grifei.

Dito isso, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, visto que a matéria fática encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos existentes nos autos, o que dispensa a produção de provas em audiência, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

Sustentam os réus, em síntese, não estarem presentes os requisitos necessários para compeli-los ao fornecimento dos medicamentos descritos na exordial.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT de f. 18/29 foi parcialmente desfavorável e apresentou as seguintes conclusões:

> *"(...) Segundo laudo médico, a requerente é portadora de Sequelas de Hipóxia Perinatal, desencadeia atraso no desenvolvimento neuromotor associado a Retardo mental grave e Epilepsia (não informou os CIDs das doenças). Solicita os medicamentos Levetiracetam 750/250mg (Keppra), Baclofeno 10mg, Domperidona 10mg, Clobazam 10mg (Frisium) para o seu tratamento. O atraso do desenvolvimento está associado a várias condições da infância, desde a concepção, gravidez e parto, decorrentes de fatores adversos como a subnutrição, agravos neurológicos, como a encefalopatia crônica da infância (paralisia cerebral), e genéticos, como a síndrome de Down. O atraso pode ser também uma condição transitória, não sendo possível definir qual será o desfecho do desenvolvimento da criança, o que pressupõe o acompanhamento com avaliações periódicas. Observa-se, ainda, não ser incomum encontrar o termo como diagnóstico, sem uma definição mais objetiva do que está acontecendo com a criança. (...) A Epilepsia é uma doença que se caracteriza por uma predisposição permanente do cérebro em originar crises epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais destas crises. A epilepsia está associada a uma maior mortalidade (risco de acidentes e traumas, crises prolongadas e morte súbita), a um risco aumentado de comorbidades psiquiátricas (sobretudo depressão e ansiedade) e também a inúmeros problemas psicossociais (perda da carteira de habilitação, desemprego, isolamento social, efeitos adversos dos fármacos, disfunção sexual e estigma social). (...) Retardo mental diz respeito a limitações significativas no funcionamento Intelectual. (...) O Keppra (nome comercial) Levetiracetam (princípio ativo) é um derivado da*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*pirrolidona quimicamente não relacionada com substâncias ativas antiepilépticas existentes. O mecanismo de ação do levetiracetam ainda não é elucidado completamente, mas parece ser diferente dos mecanismos antiepilépticos já existentes. (...) O Baclofeno (princípio ativo) é um antiespástico de ação medular altamente eficaz. Seu mecanismo de ação e propriedades farmacológicas o diferenciam de outros agentes antiespásticos. O baclofeno deprime a transmissão do reflexo monossináptico e polissináptico através da estimulação dos receptores GABA. Esta estimulação, por sua vez, inibe a liberação dos aminoácidos excitatórios, glutamato e aspartato. A transmissão neuromuscular não é afetada pelo baclofeno. (...) Domperidona (princípio ativo) é um antagonista da dopamina com propriedades antieméticas. A domperidona não atravessa imediatamente a barreira hematoencefálica. Os seus efeitos antieméticos podem ser devidos a uma combinação de um efeito periférico (gastrocinético) com o antagonismo dos receptores dopaminérgicos na zona quimioreceptora de gatilho, que fica fora da barreira hematoencefálica. Estudos em humanos mostram que a domperidona aumenta a pressão esofágica inferior, melhora a motilidade antroduodenal e acelera o esvaziamento gástrico. Não há qualquer efeito sobre a secreção gástrica. (...) Frisium (nome comercial) Clobazam (princípio ativo) é um fármaco da classe dos benzodiazepínicos, e está indicado no tratamento da ansiedade em todas as suas formas, após a exclusão de causa orgânica, e da epilepsia do adulto e da criança em associação ao tratamento anticonvulsivante de base. Os benzodiazepínicos atuam seletivamente em vias polissinápticas do SNC. Os mecanismos e os locais de ação precisos não estão ainda totalmente esclarecidos. (...) O Levetiracetam, Baclofeno, Domperidona não estão padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como não constam no rol de medicamentos da Portaria GM/MS nº 2982 de 26/11/2009. O Levetiracetam é oferecido através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Epilepsia, Portaria Conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018, com indicações especificadas no item II. Clobazam está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*(RENAME), através do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), oferecidos através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Epilepsia. (...) Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao Estado fornecer Levetiracetam 750/250mg e Clobazam 10mg através do PCDT (desde que a paciente permaneça cadastrada no Protocolo Clínico e atenda os critérios de inclusão) e desfavorável ao pedido de Baclofeno 10mg, Domperidona 10mg"* (f. 18/29).

Vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156 – RJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, assentou a possibilidade de fornecimento pelo Poder Público de medicamento não padronizado na RENAME. Senão vejamos:

*"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

> *disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."* (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Grifei.

Quanto aos medicamentos "Keppra 750 mg, Keppra 250 mg e Frisium 10 mg", observo que o parecer técnico do N.A.T. foi favorável ao fornecimento do Estado à autora, de modo que é inegável o dever estatal de fornecer estes fármacos ao paciente que necessita.

Deve-se ressalvar, todavia, a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, o qual necessariamente contém o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. Veja-se a jurisprudência:

> *"MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESENÇA. MEDICAMENTO QUE NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*DESOBRIGAR O ENTE PÚBLICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GENÉRICO. (...) A ausência do medicamento na lista do SUS não impede o seu fornecimento pelo Estado, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade do requerente arcar com seu custo. Deve-se possibilitar ao ente público o fornecimento de medicamento de outro fornecedor além daquele indicado pelo médico desde que idêntico em sua composição, sem alterar, acrescer ou retirar componente, caso em que, por um lado, seria capaz de atingir a mesma finalidade e, por outro, prestigiar-se-ia o princípio da eficiência na gestão de recursos públicos. Faz-se necessária a apresentação e retenção da receita médica, preservando a integridade do tratamento médico, devidamente acompanhado."* (TJMG - Mandado de Segurança n. 092087-95.2012.8.13.00. Relator Desembargador Jair Varão. 3ª Câmara Cível. Julgado em 08.1.2012) Grifei.

*"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDICAÇÃO POR GENÉRICO. POSSIBILIDADE. (...) I - O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).Saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da C. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. II - O medicamento genérico contém o mesmo fármaco ou princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, administrado pela mesma via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência. Para*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*alem disso, o Ministério da Saúde, através da ANVISA, avalia os testes de bioequivalência entre o genérico e o medicamento de referência. Seu uso, por isso e em princípio, é seguro não havendo contra-indicação a que possa substituir o medicamento de referência. (...)"* (TJRS - Apelação Cível Nº 70031710452, Vigésima Primeira Câmara Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 02/09/2009) Grifei.

Diante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se de forma inequívoca a presença das enfermidades indicadas na prefacial, razão pela qual a responsabilidade dos réus pelo fornecimento do produto necessário ao tratamento médico ao paciente que dele necessita é evidente, visto que garantido pela própria Constituição Federal. Quanto ao tema, a doutrina assevera o seguinte entendimento:

*"(...) E há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais"* (José Afonso da Silva *in* Curso de Direito Constitucional Positivo – 26. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional, até a Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005 – São Paulo: Malheiros, 2006. p. 308)

Veja-se a jurisprudência do c. STJ:

*"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido."* (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, j. 26/06/2007, DJ 30/08/2007 p. 219) Grifei.

*"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. 1. Esta Corte em reiterados precedentes tem reconhecido a responsabilidade solidária do entes federativos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que concerne à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos a pacientes portadores de doenças consideradas graves. 2. Agravo regimental não provido."* (AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 11/06/2008) Grifei.

Veja-se a jurisprudência do e. TJMS:

*ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ARTIGO 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO PARA FORNECER MEDICAMENTO AOS NECESSITADOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE UM, DE ALGUNS OU DE TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ATESTADO MÉDICO INFORMANDO QUE A PARTE-AUTORA É PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E QUE O MEDICAMENTO*



Mod. 796972 - Endereço: Av. Juca Pinhé, 270, Jardim Santa Mônica - CEP 79500-000, Fone: (67) 3668-1812, Paranaíba-MS - E-mail: prb-2vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

*ISCOVER 75 MG É INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Nos termos do artigo 196 da CF, há solidariedade na assistência à saúde pela União, pelo Estado e pelo Município, podendo a ação que tem por objeto o fornecimento de medicamento ser ajuizada em face de todos, de alguns ou de apenas um. II. A existência de convênios entre a União, Estados e Municípios legitima a Fazenda Pública Estadual a exigir dos demais entes a sua participação nos gastos independentemente de determinação judicial ou de participação do referido ente no feito. III. Havendo laudo médico informando a doença a qual está acometida a parte-autora, bem como o medicamento indispensável para o tratamento da paciente, somando-se ao fato de que a União, o Estado e o Município têm o dever de garantir a saúde a todos os que dela necessitam, não é crível que vise o Estado, por meio de edição de uma Portaria, a restringir o alcance de uma norma constitucional (artigo 196), a ponto de vedar um direito garantido. IV. Não é possível a condenação do Estado, de suas autarquias e fundações ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão entre credor e devedor. V. Recurso parcialmente provido.* (TJMS-3ªT., Proc. 2008.009815-7, Rel. Oswaldo Rodrigues de Melo, Jul. 05/05/2008) Grifei.

Quanto aos medicamentos "Baclofeno 10 mg e Domperidona 10 mg", no caso dos autos, embora o laudo médico de f. 71/72 demonstre a necessidade dos medicamentos para o tratamento da moléstia, não demonstra a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, um dos requisitos apresentados no julgamento do REsp nº 1.657.156.

Destarte, tendo em vista que, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos três requisitos mencionados nesta fundamentação, o pleito autoral deve ser julgado improcedente neste ponto.





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.

Vale anotar que, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fl. 122).

Ante todo o exposto, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na prefacial para o fim de CONDENAR o Município de Paranaíba e o Estado de Mato Grosso do Sul a fornecerem à autora Karen Vitória Leal de Araújo, gratuitamente, os fármacos denominados "Keppra 750 mg, Keppra 250 mg e Frisium 10 mg", conforme prescrição médica, ressalvada a possibilidade de fornecimento do medicamento genérico, convalidando a decisão de f. 56/64.

Sem condenação nas custas processuais, nos termos do art. 24, inciso I, da Lei Estadual 3.779/2009. Incabível a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Condeno o Município de Paranaíba ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, tendo em vista a reduzida complexidade e duração da demanda.

Sentença sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, 01 de agosto de 2019.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
*Assinado digitalmente*





Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 07/08/2019 às 10:21 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0804927-82.2018.8.12.0018 e código kntSmjOq.